

1. Накладання турнікету САТ; кровотеча

Сценарій.

Ви черговий лікар лікарні. Самозвернення, постраждалий 40 років з ножовим пораненням нижньої третини лівого стегна та артеріальною кровотечею із рани, що продовжується.

Скарги: на інтенсивний біль у рані на лівому стегні, кровотечу з рани, загальну слабкість. Анамнез захворювання: Травма отримана 20 хвилини тому, був поранений у ліве стегно ножом знайомим. Після чого відчув сильний біль у місці травми, почалася кровотеча, що стало причиною звертання пацієнта до найближчої лікарні.

Анамнез життя: Цукровий діабет, туберкульоз, гепатити, сифіліс, ВІЧ-інфекцію заперечує. Хворів ГРВІ. Операцій та травм не було. Алергічних реакцій немає.

Спадковість: необтяжена.

Об'єктивно: стан тяжкий, у свідомості. Шкіра бліда, суха. Ріст 180 см, вага 83 кг.

Периферичний набряків немає. При порівняльній перкусії: ясний легеневиий звук. При аускультатії легень справа - жорстке дихання; зліва дихання послаблене нижче 5 ребра не вислуховується. ЧДР 28 за хв. Межі відносної серцевої тупості не розширені. Тони серця ясні ритмічні, патологічних шумів немає. ЧСС=Пс=120 за хв., АТ ліва рука 85/60 мм рт.ст., АТ права рука 80/ 60 мм рт.ст. Живіт не роздутий, приймає участь у акті дихання. При пальпації м'який безболісний. Печінка не виступає з під краю реберної дуги.

Симптом Щоткіна-Блюмберга негативний. Аускультативно - перистальтика є. Ділянка попереку без патології. Нирки не пальпуються. Симптом Пастернацького негативний з обох боків. Випорожнення та сечовипускання без особливостей. Локальний статус. По внутрішньої поверхні нижньої третини лівого стегна рана розмірами 9х2 см, з рівними краями, кровоточить, кров яскраво червоного кольору.

Додатково:

Клінічний аналіз крові

Показник	Значення	Референтні значення
Гемоглобін г/л	70	130-160г/л – для чоловіків 120-140г/л - для жінок
Еритроцити $10^{12}/л$	1,6	4,0-5,0 $\times 10^{12}/л$ – для чоловіків 3,9-4,7 $\times 10^{12}/л$ – для жінок
Кольоровий показник	0,69	0,85-1,15
Тромбоцити $10^9/л$	205	180-320 $\times 10^9/л$
Лейкоцити $10^9/л$	12,0	4,0-9,0 $\times 10^9/л$
- лімфоцити%	22	19-37%

- еозінофіли %	3	0,5-5,0%
- палочкоядерні нейтрофіли %	5	0-5,0%
- сегментоядерні нейтрофіли %	72	47,0-72,0%
- моноцити %	8	3,0 – 11,0 %
ШОЕ	18	1 – 10 мм/ч – для чоловіків 2 – 15 мм/ч – для жінок

Клінічний аналіз сечі

Показник	Значення	Референтні значення
Колір - жовта	жовта	Різні відтінки жовтого кольору
Прозорість	прозора;	прозора;
Реакція	нейтральна	pH менше 7
Питома вага	1,021 г/л	1,012 г / л– 1,022 г / л
Лейкоцити	0-2 в полі зору.	0-6 в полі зору для жінок; 0-3 в полі зору для чоловіків;
Епітелій плоский	1-5 в полі зору.	0-10 в полі зору.
Білок	відсутній	відсутній
Еритроцити	20-25 в полі зору	0-3 в полі зору для жінок; 0-1 в полі зору для чоловіків;
Слиз	відсутня	відсутня
Солі	відсутні	відсутні
Глюкоза	відсутня	відсутня
Циліндри	відсутні	відсутні

12. Інструкція для стандартизованого пацієнта (за необхідності, якщо це передбачено умовами роботи на станції).

№п/п	Дії	Текст
1.Комунікативні навички		
1.1	Привітатися.	Доброго дня.
1.2	Ви даєте свою згоду на проведення клінічного обстеження?	Так
Збір скарг та анамнезу		
2.1	Які у Вас скарги?	На біль у лівому стегні, наявність рани та кровотечу з неї, слабкість
2.2	Коли з'явилися скарги, що з Вами трапилось?	Біля 20 хв тому отримав удар ножом у стегно
2.3	Якими захворюваннями перехворіли? Чи є алергія? Чи були операції?	Цукровий діабет, туберкульоз, гепатити, сифіліс, ВІЧ-інфекцію заперечує. Хворів ГРВІ. Операцій та травм не було. Алергічних реакцій немає. Спадковість: необтяжена.
3.Об'єктивне обстеження		
3.1	Огляд з верифікацією виявлених патологічних змін.	Я проводжу огляд з верифікацією виявлених патологічних змін Я бачу поранення в нутрішньої поверхні нижньої третини лівого стегна, рана глибока, з рівними краями. Кровоточить яскраво червонною кров'ю, що витікає пульсуючим струменем — ознаки артеріальної кровотечі. Пацієнт блідий, дезорієнтований, дихання

		прискорене.
3.2	Пальпація з верифікацією виявлених патологічних змін	Я виконую пальпацію з верифікацією виявлених патологічних змін Я палькую ліву нижню кінцівку, особливо ділянку ураження. Визначаю напруження тканин довкола рани, відсутність масивного набряку. Перевіряю пульсацію магістральних артерій нижче місця поранення (підколінна, артерії стопи) — пульсація послаблена.
3.3	Перкусія з верифікацією виявлених патологічних змін	Я виконую перкусію з верифікацією виявлених патологічних змін . У рамках перкусії перевіряю наявність підшкірного крововиливу (гематоми), змін у м'язах навколо зони ураження — перкуторно виявляю обмежену зону притуплення, що може відповідати підшкірній гематомі
3.4	Аускультация з верифікацією виявлених патологічних змін	Я оцінюю дихання, пульс, артеріальний тиск, тип кровотоку (0,5): Я фіксую ЧСС = 120/хв., АТ = 85/60 мм рт.ст. (ознаки гіповолемії), ЧДР = 28/хв. Кров яскраво-червона, витікає струменем, що свідчить про артеріальну кровотечу. Це вимагає негайного втручання
4.Діагностика		
4.1	Проаналізувати клінічний аналіз крові	Я аналізую клінічний аналіз крові та сечі Я бачу ознаки тяжкої анемії: гемоглобін — 70 г/л, еритроцити — $1,6 \times 10^{12}/л$, кольоровий показник — 0,69. В сечі — еритроцити 20–25 в полізорі, що може бути наслідком системної гіперперфузії чи травматичної мікрогематурії. Лейкоцитоз — $12,0 \times 10^9/л$ як реакція на стрес.
4.2	Проаналізувати оглядову рентгенографію органів грудної клітини	-----
4.3	Встановити попередній клінічний діагноз	Різна рана нижньої третини лівого стегна. Артеріальна кровотеча. Постгеморагічна анемія. Гіповолемічний шок II ступеня.

5. Визначення тактики ведення та лікування		
5.1	Медикаментозна терапія, фізіотерапія, особливості харчування	Я негайно накладаю турнікет типу САТ вище зони ураження для зупинки кровотечі. Провожу інфузійну терапію: розчини кристалоїдів і колоїдів(ГЕК 10%), готую до переливання еритроцитарної маси. Надаю анальгезію(дексалгін), вводжу антибіотик широкого спектра. Після стабілізації — оперативна обробка рани в умовах операційної. Харчування — тимчасово обмежене до стабілізації гемодинаміки.
6.Профілактика та пропаганда здорового способу життя		
6.1	Рекомендувати профілактичні заходи	Я наголошую на важливості уникнення небезпечних соціальних ситуацій, конфліктів, дотримання безпеки в побуті. Надалі рекомендую проходити планові огляди, укріплювати здоров'я, не зволікати з медичною допомогою при травмах.
7.Інше		
7.1	Інформування пацієнта про можливі ризики хвороби	Я інформую пацієнта про можливі ризики травми Я пояснюю, що через втрату великого об'єму крові пацієнт ризикує отримати шок, втрату свідомості, ураження внутрішніх органів. Я детально роз'яснюю необхідність екстреної допомоги, хірургічного втручання та подальшого спостереження.

Чек-лист до практичної навички «Накладання турнікету «САТ»

№ п/п	Маніпуляція	Форма представлення
1	Коректне розташування пацієнт-лікар, провести огляд постраждалого, визначити наявність свідомості та дихання.	Сказати
2	Встановлення контакту з пацієнтом. Привітатись, представитися, позначити свою роль. Попросити пацієнта представитися. Визначити особливості анамнезу (механізм травми, алергічні реакції на ліки)	Сказати
3	Отримати інформаційну згоду на проведення маніпуляції (пояснити хід та мету процедури)	Сказати

4	Одягнути медичні діагностичні	Виконати
	рукавички.	
5	Оглянути місце травми для визначення характеру ушкодження	Виконати, Сказати.
6	Підготувати турнікет САТ до накладення, розгорнувши його	Виконати,
7	Накласти турнікет у верхній частині стегна, після чого просмикніть ремінь в скобу, затягніть його до упору і зафіксуйте вільну частину ремінця, використовуючи застібку.	Виконати
8	Проводьте обертання стрижня-фіксатора до припинення кровотечі.	Виконати Сказати
9	Зафіксуйте стрижень-фіксатор в спеціальній скобі.	Виконати
Застебніть скоби липучкою і запишіть час накладення турнікету		Виконати
11	Уточнити у пацієнта його самопочуття.	Сказати
12	Завершення процедури	Сказати

